

Ureterolitíase · cólica e critérios de drenagem

Cólica nefrética típica: dor lombar em cólica + hematúria. Analgesia potente é prioridade; infecção com obstrução = drenagem de urgência.

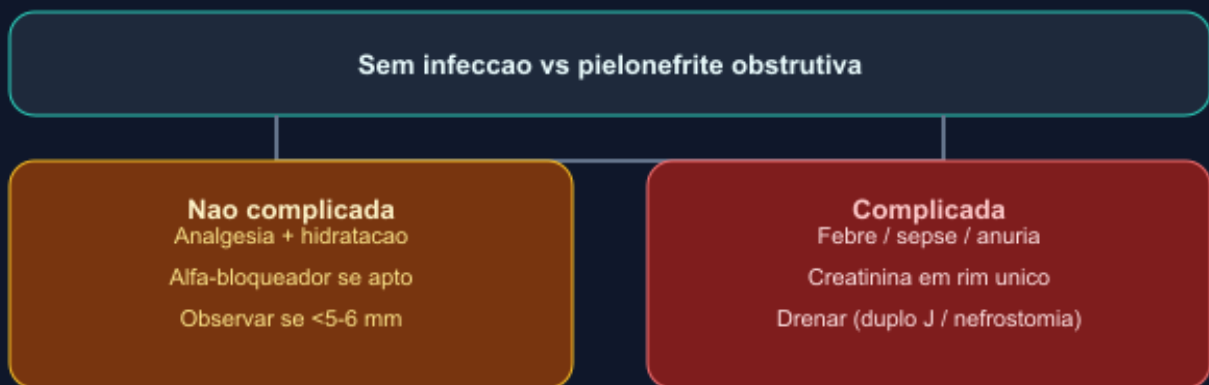
Diagnóstico

Lembre - Diagnóstico

TC sem contraste é o padrão-ouro. USG + Rx úteis na gestante/criança ou follow-up. Hematuria ajuda, mas ausência não exclui.

A bifurcação que salva rim e vida: febre + obstrução não espera eliminação espontânea.

Calculo ureteral



Conduta

- AINE (se função renal OK) ± opioide; antiemético
- Cálculos >5 mm: alta chance de eliminação; orientar filtro e retorno se febre
- <5-10 mm ou proximal persistente: maior chance de intervenção urológica
- Metafilaxia: análise do cálculo, volume hídrico, metabólico selecionado

Indicações de drenagem urgente

Indicação | Motivo

Pielonefrite obstrutiva | Risco de sepse
Anúria / rim único | Insuficiência renal
Dor refratária | Falência do conservador
Creatinina em elevação | Obstrução significativa

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Cólica + febre + dilatação piélica: ATB e desobstrução — não alta com 'analgésico e água'. AAA roto pode mimetizar cólica no idoso.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Ureterolitíase: dor em cólica + hematúria. Conduta por tamanho, localização, infecção e função renal.

Infecção com obstrução = emergência (descompressão). Tamanho guia chance de expulsão vs urologia.

Conduta por tamanho

Calculo ureteral - ideia de prova

≤5 mm

Alta chance espontanea
Analgesia + hidratacao
Alfa-bloqueador +/-

Observar

5-10 mm

Expulsao variavel
Tamsulosina frequente
Urologia se falha

Individualizar

>10 mm / infectado

Baixa expulsao espontanea
LECO/ureterosopia
Dreno se sepsis

Intervir

Imagem

Exame | Papel

TC sem contraste | Padrão-ouro: tamanho, local, densidade

USG | Hidronefrose; útil em gestante

Rx KUB | Cálculos radiopacos; seguimento

Lab | Urina I, creatinina, PCR/cultura se febre

Critérios de conduta

- Cólica simples: AINE ($\pm$ opioide), antiemético, filtro de urina
- Indicações de internação/intervenção: dor refratária, vômitos, IRA, rim único, infecção
- Pielonefrite obstrutiva / sepse: ATB + descompressão urgente (duplo J ou nefrostomia)
- "d5 mm: expectativa; >10 mm: pouco provável expulsão espontânea

Não erre

Atencao - Não erre

Febre + cálculo obstrutivo " " 'só analgésico'. Descomprimir a via urinária é prioridade.

Localização

Dica - Localização

Junção ureterovesical é sítio comum; cálculo distal pequeno tem melhor chance de eliminação que proximal do mesmo tamanho.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1